

Red de Clínicas Dentales en EE.UU.

Propuesta de Negocio e Inversión · Octubre 2026

1. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta presenta la oportunidad de construir una **red de clínicas dentales en Estados Unidos**, estructurada como una Organización de Soporte Dental (DSO), con el liderazgo de un equipo promotor que combina experiencia en gestión de redes dentales, distribución comercial y conocimiento profundo del mercado hispano.

El mercado dental de EE.UU. supera los **\$180 mil millones anuales** y continúa creciendo de forma sostenida. Existe demanda históricamente insatisfecha, especialmente en comunidades hispanas — el segmento de mayor crecimiento del país. Esta brecha representa una ventana de entrada estratégica para un equipo con las raíces culturales y lingüísticas alineadas con esa población.

El diferencial de este proyecto: El equipo promotor aporta algo que el capital solo no puede comprar — **experiencia directa en construir y operar redes de consultorios dentales**. Haber gestionado múltiples dentistas, equipos clínicos y cadenas de abastecimiento en un entorno exigente como Venezuela genera un know-how operativo que es exactamente lo que se necesita para escalar en EE.UU.

Roles del Equipo Promotor

Quién	Rol en el Proyecto
Moisés	Director Operativo — construye y gestiona la red clínica. Aporta experiencia probada en operación de redes dentales y distribución comercial.
Sady & socio	Estructura y Relaciones Públicas — arman la entidad legal y financiera, captan inversores y socios estratégicos, y gestionan las relaciones clave.
Dentista americano	Socio Clínico Legal (PC/PLLC) — figura requerida por ley en EE.UU. para la titularidad de la práctica dental. A reclutar en Fase 1.

El modelo propuesto permite a los socios:

- Construir una red clínica con estructura profesional DSO desde el primer día
- Participar como co-inversores con participación accionaria en las clínicas
- Aprovechar economías de escala en compras, distribución y marketing
- Beneficiarse de la eventual venta de la red a un DSO de mayor escala

La estructura de fondo permite que inversores externos participen bajo términos claros, con retornos proyectados sobre la inversión en un horizonte de 4 a 6 años.

2. El Mercado Dental en EE.UU.

Datos Clave del Mercado

Indicador	Cifra
Tamaño del mercado dental en EE.UU.	\$180 mil millones / año
Crecimiento anual proyectado (CAGR)	5.5% hasta 2030
Población hispana en EE.UU.	+65 millones de personas
Hispanos sin acceso dental regular	~40%
Clínicas dentales en EE.UU.	+200,000
Participación de mercado de los DSO	30% y creciendo

El Segmento Hispano: Ventaja Competitiva Clave

La comunidad hispana es el segmento de población de mayor crecimiento en EE.UU. y representa una oportunidad críticamente desatendida. Muchos pacientes hispanos prefieren ser atendidos en español y con sensibilidad cultural. Una clínica con personal bilingüe y liderazgo latinoamericano tiene una **ventaja diferencial inmediata** en mercados como Florida, Texas, California y Nueva York — donde la comunidad venezolana tiene especial presencia (Doral, Miami, Houston, Weston).

Por Qué los DSO Dominan el Futuro

Las Organizaciones de Soporte Dental (DSO) son empresas que administran el lado administrativo de múltiples clínicas, permitiendo que los dentistas se concentren en la práctica clínica. En la última década:

- Los DSO han crecido del 5% al 30% del mercado
- Las valuaciones de DSO oscilan entre **6x y 12x EBITDA**

Los fondos de capital privado invierten activamente en este sector
- La consolidación del mercado continúa acelerándose

3. Modelo de Negocio Propuesto

Estructura DSO con Socios Operadores

El modelo propuesto sigue la estructura de una **Organización de Soporte Dental (DSO) privada**, donde una empresa holding central administra la gestión, finanzas, compras, marketing y recursos humanos de múltiples

clínicas. Los socios clínicos conservan autonomía en la práctica y participan en las ganancias.

A diferencia de los DSO típicos fundados por inversores sin experiencia clínica, este proyecto parte con **liderazgo operativo probado**: el conocimiento de cómo estructurar, dotar y hacer crecer una red de consultorios no se improvisa — ya existe en el equipo.

Fuentes de Ingresos por Clínica

Servicio	% de Ingresos
Odontología general (limpiezas, empastes, extracciones)	45%
Endodoncia y cirugía oral	20%
Ortodoncia e Invisalign	15%
Implantes dentales	12%
Odontología estética	8%

Ventaja en Compras y Distribución

La experiencia en distribución y venta de productos permite estructurar **acuerdos de compra centralizada** con proveedores de insumos dentales desde una posición de fortaleza. En un DSO, el volumen de compras es uno de los principales palancas de margen — y ese músculo se desarrolla con años de experiencia comercial, no solo con capital.

4. Estructura de Inversión y Fondo

Estructura Legal: DSO + PC/PLLC

En EE.UU., la ley exige que las clínicas dentales sean propiedad de un dentista con licencia americana. Los grandes grupos DSO resuelven esto con una estructura en dos capas:

- **PC/PLLC (Professional Corporation)**: es la entidad que posee legalmente cada clínica. Debe tener un dentista americano como titular. Esta figura no necesita ser el motor del negocio — solo aporta la licencia.
- **DSO / Holding (LLC)**: es la entidad donde residen el control operativo, la propiedad económica real y la estrategia. Aquí participan el equipo promotor e inversores. Provee servicios de gestión a la PC/PLLC a cambio de un fee, capturando la mayor parte del valor.

Reclutar al socio dentista americano es parte de la Fase 1 — es un paso gestionable, no un obstáculo.

Niveles de participación en la LLC/DSO:

Nivel 1 — Socios Fundadores (Socios Generales)

Son quienes impulsan el proyecto, aportan capital inicial o *gestión operativa* y poseen la mayor participación accionaria. El aporte de experiencia en construcción de redes dentales y en relaciones

públicas y captación tiene un valor equivalente al capital — es lo que convierte una inversión en un negocio real.

Nivel 2 — Socios Clínicos (Socios Operadores)

Dentistas que se incorporan como co-inversores, aportando capital o compromiso clínico a cambio de participación accionaria (típicamente 5%–15% por clínica). El equipo promotor apoya el proceso de habilitación en EE.UU. donde sea necesario.

Nivel 3 — Inversores Pasivos (Socios Limitados)

Personas o entidades que aportan capital sin participar en las operaciones. Reciben retornos preferentes y una proporción de los beneficios de la venta final.

Estrategia de Salida

El principal mecanismo de creación de riqueza en el modelo DSO es **la venta de la red a un DSO más grande o a un fondo de capital privado**:

Escenario de Venta	Múltiplo EBITDA	Retorno Estimado
Venta en Año 3 (red pequeña, 2–3 clínicas)	5x – 7x	Moderado
Venta en Año 5 (red mediana, 5+ clínicas)	8x – 12x	Alto
OPI o venta estratégica	12x+	Máximo

5. Proyecciones Financieras

Proyección por Clínica (Año Estabilizado, Año 2–3)

Línea	Valor Estimado
Ingresos brutos anuales	\$1,500,000 – \$2,500,000
Costos de personal clínico y operativo	40%–50%
Alquiler y costos fijos	10%–15%
Marketing y administración	8%–12%
EBITDA (margen neto operativo)	18%–28%
EBITDA anual por clínica	\$270,000 – \$700,000

Proyección de Red (5 Clínicas al Año 5)

Indicador	Valor Proyectado
Ingresos totales de la red	\$10M – \$15M
EBITDA total de la red	\$2M – \$4M
Valuación estimada (8x EBITDA)	\$16M – \$32M
Inversión total estimada (5 clínicas)	\$2.5M – \$5M
ROI estimado para inversores	3x – 6x sobre el capital invertido

6. Plan de Ejecución

Fase 1 — Fundación (Meses 1–6)

- Constituir la entidad legal (LLC/DSO holding) en Delaware o Florida
- Reclutar al socio dentista americano para la PC/PLLC — figura legal requerida
- Definir acuerdos de socios y pacto de accionistas entre los fundadores
- Identificar y pre-calificar socios clínicos latinoamericanos interesados
- Realizar estudio de mercado en 2–3 ciudades objetivo (Miami/Doral, Houston, Orlando)
- Establecer primeros acuerdos de distribución y compras centralizadas con proveedores dentales
- Asegurar capital inicial (Fase 1: \$500K – \$800K)

Fase 2 — Primera Clínica (Meses 7–18)

- Seleccionar ubicación estratégica en mercado con alta concentración hispana y venezolana
- Negociar arrendamiento comercial
- Equipar e instalar la clínica (~\$200K – \$400K) aprovechando red de proveedores
- Contratar y onboardear personal clínico y administrativo
- Lanzar con campaña de marketing digital bilingüe (español-inglés)
- Meta: 200–400 pacientes activos en el primer año

Fase 3 — Expansión (Años 2–5)

- Abrir 1–2 clínicas adicionales por año usando flujo de caja y modelo operativo probado
- Escalar acuerdos de distribución a nivel de red (mayor volumen = mejores precios)
- Levantar segunda ronda de inversores para acelerar el crecimiento
- Preparar la red para valuación y proceso de venta estratégica

7. Por Qué Ahora — La Ventana de Oportunidad

Varios factores convergen para crear una ventana de oportunidad excepcional:

Demanda post-pandémica contenida. Millones de estadounidenses postergaron tratamientos dentales durante 2020–2022. La demanda de odontología preventiva y estética se mantiene por encima de los niveles históricos.

Crecimiento demográfico hispano. La población hispana en EE.UU. creció un 23% en la última década. Es el mercado más dinámico para los servicios de salud y el que más valora la atención en su idioma y cultura.

Múltiplos de valuación históricamente altos. Los DSO se están vendiendo a múltiplos nunca vistos antes en odontología. Grupos como Aspen Dental, Pacific Dental y Heartland Dental adquieren activamente redes más pequeñas.

El perfil que el mercado necesita — y que este equipo ya tiene. Construir un DSO exitoso no requiere solo capital: requiere saber cómo reclutar y gestionar dentistas, cómo negociar con proveedores, cómo estandarizar procesos clínicos y cómo hacer crecer una base de pacientes. Ese conocimiento, acumulado durante años de operación de redes dentales en Venezuela y de distribución comercial, es el activo más difícil de replicar y el que define si un DSO escala o se estanca.

Tecnología que reduce los costos de apertura. El software de gestión dental (CRM, radiología digital, telerradiología) ha reducido los costos de entrada y mejora los márgenes desde el primer año de operación.

8. Próximos Pasos

Esta propuesta es un primer borrador para abrir la conversación. No se requiere ningún compromiso de capital en esta etapa.

Paso 1 — Reunión Exploratoria (esta semana)

Una conversación para alinear visión, definir los roles de cada socio y evaluar el interés en participar como socio fundador, clínico o pasivo.

Paso 2 — Due Diligence Básico (Mes 1)

- Mapear contactos dentales disponibles y dispuestos a participar
- Definir presupuesto inicial y capacidad de inversión de cada socio
- Seleccionar 2–3 ciudades objetivo y validar demanda local

Paso 3 — Carta de Intención (Mes 2)

Un documento no vinculante que formaliza el interés mutuo, define el rol de cada socio y establece los términos generales del acuerdo antes de incurrir en gastos legales.

Paso 4 — Constitución Legal y Cierre de Primera Ronda (Meses 3–6)

Con un abogado especializado en estructuras de negocios dentales en EE.UU., constituir la LLC y cerrar los primeros compromisos de capital.

Esta propuesta fue preparada como punto de partida para la conversación. Las proyecciones son estimaciones direccionales basadas en benchmarks públicos del sector DSO en Estados Unidos. Se recomienda asesoría legal y financiera especializada antes de asumir cualquier compromiso formal.